Estilo UERJ

Simulado 4 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

80 questões

15 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 80 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 4 horas, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Homem de 66 anos, ex-carregador de sacos em armazém, com cervicalgia há anos, tem há 10 meses fraqueza progressiva das mãos, dificuldade para abotoar a camisa e marcha 'presa'. Nega disfagia, alteração da voz e alteração esfincteriana. Exame: atrofia de interósseos bilateral, fasciculações em bíceps e deltoides, reflexo bicipital reduzido com tricipital vivo, Hoffmann bilateral, espasticidade e Babinski bilaterais em membros inferiores; língua sem atrofia. RM de coluna cervical: estenose do canal em C4-C5 e C5-C6, com hipersinal medular discreto em T2 em C5. A cirurgia de descompressão é programada. Ao rever o exame antes da cirurgia, o achado adicional que, isoladamente, não pode ser atribuído à compressão cervical e obriga a investigar doença do neurônio motor é:

A) Clônus aquileu bilateral

B) Reflexo mandibular exaltado

C) Sensibilidade tátil e vibratória normais

D) Sinal de Lhermitte

---

2 Mulher de 30 anos, quatro meses após o parto, em aleitamento materno exclusivo, refere palpitações, irritabilidade e insônia há três semanas. Tem anti-TPO positivo documentado no primeiro trimestre, com TSH normal na gestação; a irmã tem doença de Graves. Sem dor cervical ou febre. Exame: FC 104 bpm, tremor fino, tireoide discretamente aumentada, indolor, sem sopro, sem oftalmopatia. Exames: TSH abaixo de 0,01 µUI/mL, T4 livre 2,6 ng/dL (0,8 a 1,8), T3 total 168 ng/dL (80 a 200), TRAb negativo, VHS 12 mm/h. O diagnóstico mais provável é:

A) Tireoidite subaguda granulomatosa

B) Tireotoxicose factícia

C) Doença de Graves no pós-parto

D) Tireoidite pós-parto

---

3 Mulher de 52 anos percebeu nódulo axilar esquerdo há 1 mês. Exame: linfonodo axilar de 3 cm, móvel; mamas sem nódulos à palpação, sem alterações cutâneas ou papilares. Biópsia por agulha grossa do linfonodo: metástase de adenocarcinoma pouco diferenciado; imuno-histoquímica com CK7 positiva, CK20 negativa, GATA3 positiva, receptor de estrogênio positivo e HER2 negativo. Mamografia e ultrassonografia mamárias bilaterais sem lesões suspeitas (BI-RADS 1). TC de tórax e abdome sem outras lesões. O próximo exame mais adequado é:

A) Endoscopia e colonoscopia

B) PET-CT com FDG

C) Marcadores CA 15-3 e CEA

D) Ressonância magnética das mamas

---

4 Homem de 64 anos, no 2º dia de UTI por choque séptico de foco urinário (Escherichia coli em hemoculturas, sensível à ceftriaxona em uso desde a admissão, sem obstrução à ultrassonografia), recebeu 30 mL/kg de cristaloide nas primeiras 3 horas e hoje não responde a volume pela elevação passiva das pernas. Está há 6 horas com noradrenalina, agora em 0,32 mcg/kg/min, para manter PAM de 65 mmHg. Lactato 3,1 mmol/L, diurese 0,4 mL/kg/h. Ecocardiograma à beira do leito: FE de 60%, sem derrame pericárdico, veia cava inferior distendida. Não usa corticoide cronicamente. Segundo a Surviving Sepsis Campaign, associar vasopressina e iniciar hidrocortisona são condutas, respectivamente:

A) Indicada / indicada

B) Indicada / não indicada

C) Não indicada / indicada

D) Não indicada / não indicada

---

5 Homem de 61 anos procura atendimento por febre diária de até 39,8 °C há 7 semanas, com picos ao entardecer, sudorese noturna, perda de 9 kg e artralgia de punhos e joelhos. Nos picos febris aparece exantema macular rosado em tronco, que some com a defervescência. Exame físico: linfonodos cervicais e axilares de 2 a 3 cm, endurecidos, indolores e coalescentes à esquerda, baço a 5 cm do rebordo costal, artrite de punhos. Exames: Hb 9,8 g/dL, leucócitos 16.900/mm³ (84% neutrófilos), plaquetas 470.000/mm³, ferritina 9.600 ng/mL, AST 72 U/L, LDH 1.240 U/L (VR até 250), FAN e fator reumatoide não reagentes, hemoculturas e sorologias para HIV, hepatites, EBV, CMV e toxoplasmose negativas, ecocardiograma normal. TC: linfonodomegalias retroperitoneais confluentes de até 4 cm. O próximo exame mais adequado é:

A) Biópsia de pele do exantema

B) PET-CT de corpo inteiro

C) Ferritina glicosilada

D) Biópsia excisional de linfonodo

---

6 Homem de 58 anos, tabagista, chega à UPA com dor torácica em aperto há 90 minutos. ECG: supradesnivelamento de ST em DII, DIII e aVF, maior em DIII do que em DII, com infradesnivelamento em DI e aVL. Recebe AAS e, para a dor, um comprimido sublingual. Quinze minutos depois está sudoreico e confuso, PA 72×40 mmHg, FC 64 bpm, turgência jugular a 45 graus, pulmões limpos, sem sopros, SpO2 96% em ar ambiente. O mecanismo principal da hipotensão é:

A) Vasodilatação arterial periférica pelo nitrato

B) Reflexo vagal de Bezold-Jarisch

C) Pré-carga reduzida num VD isquêmico

D) Falência sistólica do ventrículo esquerdo

---

7 Mulher de 59 anos, com doença renal crônica por nefroesclerose hipertensiva, TFGe de 22 mL/min/1,73 m², não dialítica, sem fraturas, em uso de losartana e anlodipino. Trabalha em casa e quase não se expõe ao sol. Exames de rotina: cálcio 8,9 mg/dL, fósforo 4,4 mg/dL, fosfatase alcalina 112 U/L (normal), bicarbonato 23 mEq/L e PTH 196 pg/mL (15 a 65), que era 142 pg/mL há seis meses. No prontuário, o residente anotou que o rim doente produz menos vitamina D ativa. Para orientar o manejo do PTH em elevação, o exame mais adequado neste momento é:

A) 1,25-di-hidroxivitamina D sérica

B) Cintilografia de paratireoides

C) 25-hidroxivitamina D sérica

D) Densitometria óssea

---

8 Um teste rápido para uma infecção tem sensibilidade de 80% e especificidade de 90%. Para um paciente com probabilidade pré-teste de 50%, a razão de verossimilhança positiva do teste e a probabilidade de doença após um resultado positivo são, respectivamente:

A) 0,89 / 80%

B) 8 / 80%

C) 0,89 / 89%

D) 8 / 89%

---

9 Homem de 34 anos, sem comorbidades, IMC de 23 kg/m², abstêmio, é encaminhado por ALT discretamente elevada em exame admissional. Está assintomático. Nunca recebeu transfusão e não usa suplementos, anabolizantes nem medicamentos. Exame físico normal, sem hepatomegalia. Ultrassonografia de abdome sem esteatose e sem alterações. Exames em jejum, repetidos com 1 mês de intervalo: saturação de transferrina de 71% e 68% (VR 20 a 50%), ferritina de 380 e 410 ng/mL (VR 30 a 400), ALT 52 U/L, AST 41 U/L, glicemia e hemograma normais. Sorologias para hepatites B e C negativas. O próximo exame mais adequado é:

A) Ressonância hepática com T2*

B) Biópsia hepática com coloração de Perls

C) Pesquisa da mutação C282Y do HFE

D) Repetir o perfil de ferro em 6 meses

---

10 Homem de 71 anos, hipertenso em uso de losartana, etilista de cerca de cinco latas de cerveja por dia e que bebeu mais no último fim de semana, chega à emergência com dor abdominal periumbilical súbita e intensa há 5 horas, sem melhora com dipirona, seguida de dois vômitos e de uma evacuação diarreica. Nega febre, icterícia e episódios semelhantes. Exame: agitado pela dor, T 36,9 °C, PA 150 x 92 mmHg, pulso irregularmente irregular a 112 bpm, abdome flácido, com dor leve e difusa à palpação profunda, sem descompressão dolorosa, ruídos hidroaéreos presentes. Exames: leucócitos 16.800/mm³, amilase 210 U/L (até 100), lipase 95 U/L (até 60), bilirrubina total 0,9 mg/dL, lactato 1,8 mmol/L (até 2,0), creatinina 1,1 mg/dL. Radiografia de abdome em pé sem pneumoperitônio. O diagnóstico mais provável é:

A) Pancreatite aguda alcoólica

B) Úlcera péptica perfurada

C) Isquemia mesentérica aguda

D) Colecistite aguda

---

11 Homem de 74 anos, com diabetes tipo 2 há 20 anos, doença renal crônica (TFG estimada 38 mL/min/1,73 m²) e infarto prévio, usa glargina 24 UI à noite, glibenclamida 5 mg duas vezes ao dia, linagliptina e empagliflozina. Mora sozinho e refere tremores noturnos ocasionais. HbA1c 8,4%. Relatório de 14 dias do sensor de glicose: tempo no alvo (70 a 180 mg/dL) 49%, acima de 180 mg/dL 44%, entre 54 e 69 mg/dL 5%, abaixo de 54 mg/dL 2%, com os eventos concentrados entre 2 e 5 horas da manhã; glicose média 182 mg/dL. A conduta mais adequada agora é:

A) Trocar para esquema basal-bolus

B) Associar semaglutida semanal

C) Aumentar a glargina em 10%

D) Suspender a glibenclamida

---

12 Homem de 76 anos é internado por pneumonia. A família conta que, há 1 ano, ele tem dias bons e dias ruins de memória e atenção, vê 'crianças brincando na sala' sem se assustar, e há vários anos se debate e grita dormindo. No 2º dia de internação, agitado à noite, recebeu haloperidol 5 mg IM; na manhã seguinte estava rígido, mal deglutia e caiu ao tentar levantar. Exame: Tax 37,2 °C, rigidez plástica simétrica nos quatro membros, bradicinesia, sem tremor de repouso, desatento, CPK 240 U/L. Antes da internação andava sozinho, sem rigidez percebida pela família. A infecção está em melhora com antibiótico. O diagnóstico de base mais provável é:

A) Delirium por pneumonia

B) Doença de Parkinson com demência

C) Demência com corpos de Lewy

D) Doença de Alzheimer

---

13 Homem de 52 anos, com leucemia mieloide aguda em indução com citarabina e daunorrubicina, está no 14º dia do ciclo. Usa aciclovir profilático e não recebe antifúngico profilático. Iniciou febre há 5 dias, com neutrófilos de 60/mm³, e recebe cefepima desde a primeira hora. Continua com picos de 38,6 °C, sem tosse, dispneia, dor torácica, diarreia, dor abdominal ou lesões de pele; mucosite oral leve; cateter totalmente implantado sem sinais flogísticos. Exame: FC 102 bpm, PA 118 × 72 mmHg, FR 18 irpm, SpO2 96% em ar ambiente, ausculta pulmonar normal. Hemoculturas (cateter e periférica) e urocultura colhidas na admissão e no 3º dia: negativas. Radiografias de tórax na admissão e ontem: normais. Neutrófilos hoje: 40/mm³. O próximo exame mais adequado é:

A) Nova radiografia de tórax

B) Ultrassonografia de abdome

C) Ecocardiograma transtorácico

D) TC de tórax

---

14 Na dermatomiosite do adulto, o período de maior risco de surgimento de neoplasia associada é:

A) Entre 3 e 5 anos após o diagnóstico

B) Entre 5 e 10 anos após o diagnóstico

C) Constante ao longo de toda a doença

D) Entre 1 ano antes e 3 anos após o diagnóstico

---

15 Homem de 54 anos, hipertenso e diabético, nascido na zona rural do norte de Minas Gerais, onde viveu até os 20 anos em casa de pau a pique, refere palpitações e dispneia aos médios esforços há 8 meses. Nega angina. PA 132×80 mmHg, FC 58 bpm, B3, sem sopros. ECG: bradicardia sinusal, bloqueio completo de ramo direito, bloqueio divisional anterossuperior esquerdo e extrassístoles ventriculares polimórficas. Ecocardiograma: FE 38%, aneurisma apical do VE e hipocinesia inferolateral. Troponina normal. O próximo exame mais adequado é:

A) Cineangiocoronariografia

B) Sorologia para T. cruzi

C) Ressonância cardíaca com realce tardio

D) Cintilografia de perfusão miocárdica

---

16 Homem de 49 anos, com transtorno bipolar em uso de carbonato de lítio 900 mg/dia há dez anos (litemias anteriores entre 0,7 e 0,9 mEq/L), torceu o tornozelo há dez dias e passou a tomar, três vezes ao dia, um comprimido para dor e inchaço comprado sem receita. Há três dias tem diarreia e tremor grosseiro, e hoje ficou confuso. Exame: Glasgow 10, mioclonias, hiper-reflexia, PA 118/72 mmHg, FC 56 bpm. Exames: creatinina 2,1 mg/dL (basal 1,0), sódio 141 mEq/L, potássio 4,3 mEq/L, litemia de 2,6 mEq/L colhida 12 horas após a última dose. ECG: bradicardia sinusal e QTc de 470 ms. Além de suspender o lítio e o analgésico, a conduta mais adequada é:

A) Carvão ativado em doses múltiplas

B) Diurese forçada com furosemida

C) SF 0,9% e nova litemia em 6 horas

D) Hemodiálise

---

17 Homem de 64 anos procura atendimento por perda de 7 kg e sudorese noturna há 4 meses, com diarreia e pesquisa de sangue oculto positiva. Exame: linfonodos cervicais, axilares e inguinais de 2 a 4 cm, baço a 6 cm do rebordo costal. Hemograma: Hb 10,8 g/dL, leucócitos 46.000/mm³ com 78% de linfócitos pequenos a médios de contorno nuclear irregular, plaquetas 112.000/mm³. LDH 410 U/L. Imunofenotipagem do sangue periférico: CD19+, CD20+ forte, CD5+, CD23 negativo, CD200 negativo, CD10 negativo, cadeia leve lambda restrita. Colonoscopia: múltiplos pólipos pequenos no cólon. O diagnóstico mais provável é:

A) Leucemia linfocítica crônica

B) Linfoma folicular

C) Linfoma da zona marginal esplênico

D) Linfoma do manto

---

18 Homem de 71 anos, com hiperplasia prostática, está internado há 6 dias por uropatia obstrutiva com hidronefrose bilateral, tratada com sondagem vesical e, no 2º dia, nefrostomia percutânea à direita após tentativa frustrada de cateter duplo J. Há 2 dias tem dispneia leve e dor lombar direita. Afebril, PA 136 × 82 mmHg, FC 88 bpm, SpO2 94% em ar ambiente. Radiografia: derrame pleural direito novo, de volume moderado. Toracocentese: líquido citrino e claro, pH 7,12, glicose 98 mg/dL, proteína 0,9 g/dL (sérica 6,4), LDH 82 U/L (sérica 240; limite superior da normalidade 250), 300 células/mm³, Gram sem bactérias. Creatinina sérica 2,3 mg/dL. A classificação do líquido e o passo seguinte mais adequado são, respectivamente:

A) Exsudato / drenagem torácica

B) Exsudato / creatinina no líquido

C) Transudato / creatinina no líquido

D) Transudato / drenagem torácica

---

19 Mulher de 81 anos com adenocarcinoma de pâncreas metastático está em fim de vida em enfermaria de cuidados paliativos (PPS 10%), sonolenta, despertando ao chamado, e aceita apenas pequenos goles de água há 3 dias. Sem dor, sem dispneia, sem agitação; urina concentrada, cerca de 300 mL/dia. A filha pede soro para que a mãe não morra de sede. Exame: mucosa oral seca, edema de membros inferiores 2+, estertores finos em bases, sem desconforto respiratório. Sódio 147 mEq/L, creatinina 1,9 mg/dL. A conduta mais adequada é:

A) Cuidado oral, sem hidratação artificial

B) Hipodermóclise com 1.000 mL/dia de soro

C) Soro glicosado 5% intravenoso

D) Sonda nasoenteral para água e dieta

---

20 Mulher de 52 anos, previamente hígida, teve há 10 semanas febre alta súbita, exantema e poliartralgia intensa durante surto de chikungunya no bairro, com RT-PCR positivo para o vírus no 3º dia. A febre cedeu em 5 dias, mas persistem dor e edema em punhos, metacarpofalangeanas e tornozelos, com rigidez matinal de 40 minutos, que a impedem de trabalhar. Usou paracetamol e dipirona, e depois ibuprofeno por 2 semanas, sem melhora. Exame: artrite de punhos, 2ª e 3ª metacarpofalangeanas bilaterais e tornozelos, tenossinovite de extensores. VHS 42 mm, PCR 2,1 mg/dL, fator reumatoide e anti-CCP não reagentes, creatinina 0,8 mg/dL, glicemia 92 mg/dL, sem hipertensão. Segundo o Ministério da Saúde, a conduta mais adequada é:

A) Metotrexato semanal

B) Hidroxicloroquina diária

C) Prednisona 0,5 mg/kg/dia com desmame

D) Manter anti-inflamatório por 3 meses

---

21 Homem de 58 anos, hipertenso, apresenta há 7 horas tontura rotatória contínua, vômitos e desequilíbrio, iniciados ao acordar, sem relação com a posição da cabeça. Teve resfriado há 10 dias. Nega hipoacusia, cefaleia e disartria. Exame: nistagmo horizontal-torcional batendo para a direita, unidirecional, que diminui com a fixação visual; teste do impulso cefálico com sacada corretiva para a esquerda; na cobertura alternada, o olho direito corrige para baixo e o esquerdo para cima a cada troca; marcha com lateropulsão para a esquerda, sem dismetria apendicular. TC de crânio sem contraste normal. O próximo passo mais adequado é:

A) Manobra de reposicionamento de Epley

B) Audiometria e prova calórica ambulatoriais

C) RM de encéfalo com difusão

D) Prednisona oral e alta

---

22 Homem de 36 anos é investigado por úlceras duodenais múltiplas e recorrentes, uma delas no jejuno proximal, diarreia crônica e gastrina de jejum de 1.400 pg/mL (até 100) com pH gástrico de 1,5, colhida após uma semana sem inibidor de bomba. Há dois anos teve prolactinoma de 8 mm, controlado com cabergolina. O pai foi operado de cálculos renais três vezes. A tomografia mostra lesão de 1,2 cm na parede duodenal e outra de 0,8 cm na cabeça do pâncreas. O exame que mais modifica a conduta neste momento é:

A) Cálcio sérico e PTH

B) Teste de estímulo com secretina

C) Ecoendoscopia pancreática

D) Cintilografia com análogo da somatostatina

---

23 Mulher de 38 anos tem artrite reumatoide diagnosticada há 4 meses (FR e anti-CCP reagentes, erosão em 1 metacarpofalângica), em uso de metotrexato 10 mg/semana por via oral desde o diagnóstico, sem ácido fólico, e prednisona 5 mg/dia. Refere aftas orais recorrentes e náusea no dia da tomada. Não consome álcool e não planeja gestação, com contracepção eficaz. Exame físico: 8 articulações dolorosas e 6 edemaciadas. Exames: CDAI 28, hemograma normal, creatinina 0,7 mg/dL, ALT 28 U/L, sorologias para hepatites B e C negativas. Radiografia de tórax normal. A conduta mais adequada é:

A) Trocar metotrexato por leflunomida

B) Associar adalimumabe

C) Metotrexato 20 mg/semana com ácido fólico

D) Aumentar prednisona para 20 mg/dia

---

24 Para controle de dispneia refratária nos últimos dias de vida de paciente com doença renal crônica dialítica que optou por suspender a hemodiálise, o opioide mais adequado é:

A) Codeína

B) Tramadol

C) Fentanil

D) Morfina

---

25 Homem de 36 anos, com IMC de 42 kg/m², apneia do sono e hipertensão em uso de anlodipino, foi encaminhado por proteinúria em exame admissional. Sem edema e sem história familiar de doença renal. Exames: proteinúria de 24 h de 4,6 g, albumina sérica 4,1 g/dL, colesterol total 214 mg/dL, creatinina 1,1 mg/dL, urina com 2 hemácias por campo, sorologias para HIV e hepatites B e C negativas, FAN negativo, C3 e C4 normais. Biópsia renal: glomeruloesclerose segmentar e focal de variante peri-hilar, com glomerulomegalia; microscopia eletrônica com apagamento segmentar dos processos podocitários. Quanto à forma da GESF, o diagnóstico mais provável é:

A) Genética, por variante podocitária

B) Primária, por fator circulante

C) Viral, por lesão podocitária direta

D) Adaptativa, por hiperfiltração

---

26 Mulher de 41 anos, sem lúpus ou outra doença autoimune, teve trombose venosa profunda femoropoplítea esquerda há 4 meses, sem fator desencadeante, tratada com rivaroxabana 20 mg/dia, sem recorrência e sem sangramento até agora; ela prefere seguir com o comprimido sem exames de controle. Tem duas perdas gestacionais após 10 semanas de gestação. Exames colhidos antes da anticoagulação mostraram anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipina IgG 82 GPL e anti-beta-2-glicoproteína I IgG 64 U, e os três se repetiram positivos após 12 semanas, em amostra tratada para remover a interferência do anticoagulante. FAN negativo, função renal normal, IMC de 26 kg/m². Quanto ao anticoagulante e à duração, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Trocar por varfarina / indefinida

B) Manter rivaroxabana / indefinida

C) Manter rivaroxabana / 6 meses

D) Trocar por varfarina / 6 meses

---

27 Homem de 54 anos trabalhou 22 anos em pedreira, com jateamento de areia e corte de granito, e tem silicose com conglomerados nos lobos superiores diagnosticada há 6 anos. É tabagista (35 maços-ano). Há 2 meses tem tosse produtiva, febre baixa vespertina, sudorese noturna e perda de 5 kg. TC de tórax: os conglomerados do lobo superior direito, estáveis há 2 anos, agora apresentam cavidade de paredes espessas de 3 cm. Leucócitos 8.900/mm³. Duas baciloscopias de escarro negativas. O próximo exame mais adequado é:

A) Broncoscopia com biópsia da lesão

B) Teste rápido molecular e cultura no escarro

C) PET-CT de corpo inteiro

D) Biópsia transtorácica guiada por TC

---

28 Homem de 72 anos, hipertenso, chega à emergência com dispneia súbita há 1 hora, sentado, agitado, muito ansioso e sudoreico. PA 206×112 mmHg, FC 118 bpm, FR 34 irpm, SpO2 84% em ar ambiente, estertores até ápices, sem sopros. Consciente, colaborativo e protegendo a via aérea. ECG: taquicardia sinusal com sobrecarga de VE, sem supradesnivelamento de ST. Radiografia: congestão bilateral em asa de borboleta. A conduta inicial mais adequada é:

A) Intubação orotraqueal imediata

B) Morfina IV e furosemida IV

C) Furosemida IV isolada em dose alta

D) VNI, nitrato IV e furosemida IV

---

29 Homem de 39 anos, agricultor em Santa Catarina, há 10 dias limpou um paiol de milho fechado havia meses, com muitas fezes de roedores. Há 4 dias tem febre de 39 °C, mialgia intensa, cefaleia, dor lombar e náuseas; há 12 horas, tosse seca e dispneia progressiva. Exame: T 38,7 °C, FR 32 irpm, FC 124 bpm, PA 92 × 58 mmHg, SpO2 86% em ar ambiente, estertores difusos bilaterais, sem icterícia, sem sufusão conjuntival, panturrilhas indolores. Hematócrito 54%, leucócitos 18.400/mm³ com desvio à esquerda e linfócitos atípicos, plaquetas 42.000/mm³, creatinina 1,4 mg/dL, potássio 4,2 mEq/L, CK 340 U/L, bilirrubina total 0,9 mg/dL. Radiografia: infiltrado intersticial bilateral, linhas B e pequeno derrame pleural bilateral. O diagnóstico mais provável é:

A) Dengue com extravasamento plasmático

B) Hantavirose cardiopulmonar

C) Pneumonia pneumocócica com sepse

D) Leptospirose com hemorragia pulmonar

---

30 Homem de 50 anos, etilista de 1 litro de cachaça por dia há 20 anos, internado há 30 horas na cirurgia para drenagem de abscesso perianal, sem beber desde a véspera da internação, apresenta duas crises tônico-clônicas generalizadas de 1 minuto cada, com 20 minutos de intervalo, recuperando a consciência entre elas. Está agora trêmulo, sudoreico e ansioso, FC 118 bpm, PA 158/94 mmHg, Tax 37,6 °C, parcialmente orientado, sem déficit focal e sem sinais de trauma. Nunca teve crise fora de períodos de abstinência. Glicemia 104 mg/dL, sódio 136 mEq/L, magnésio 1,6 mg/dL (VR 1,7 a 2,4). TC de crânio sem contraste: atrofia cortical difusa. Quanto ao tratamento agudo e à prevenção de novas crises, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Diazepam IV / sem anticrise de manutenção

B) Diazepam IV / fenitoína de manutenção

C) Fenitoína IV de ataque / sem manutenção

D) Levetiracetam IV / levetiracetam por 6 meses

---

31 Mulher de 27 anos, com síndrome dos ovários policísticos, usa há três anos o comprimido diário que a ginecologista prescreveu para regularizar a menstruação e controlar a acne, e não pretende suspendê-lo. Há oito meses ganhou 12 kg, com estrias violáceas de 1,5 cm no abdome, equimoses fáceis e hipertensão recente (PA 148/96 mmHg). Glicemia de jejum 118 mg/dL, potássio 3,9 mEq/L. Exame: fraqueza proximal ao levantar da cadeira, giba dorsal, face arredondada. O exame inicial mais adequado para rastrear hipercortisolismo nesta paciente é:

A) Cortisol após 1 mg de dexametasona

B) ACTH plasmático pela manhã

C) Cortisol salivar ao final da noite

D) Ressonância magnética de sela

---

32 Mulher de 66 anos, com infarto do miocárdio há 6 anos, usa atorvastatina 40 mg/dia desde então, sempre bem tolerada, além de AAS, metoprolol e enalapril. Há 3 meses refere dor e cãibras em coxas e panturrilhas, cansaço, dificuldade para levantar da cadeira e ganho de 5 kg. Nega medicação nova, e a filha confirma que ela toma a estatina regularmente. Exame físico: PA 148 × 92 mmHg, FC 56 bpm, força grau 4 em flexores do quadril, reflexos aquileus com fase de relaxamento lentificada, sem lesões cutâneas. Exames: CK 1.380 U/L (VR até 170), creatinina 1,2 mg/dL (1,0 há 1 ano), sódio 133 mEq/L, AST 64 U/L, ALT 38 U/L, LDL 162 mg/dL (68 mg/dL há 1 ano). Antes de decidir sobre a estatina, o exame mais adequado é:

A) Anticorpo anti-HMGCR

B) TSH e T4 livre

C) Biópsia muscular

D) Eletroneuromiografia

---

33 Homem de 54 anos com cirrose por álcool foi admitido há 20 horas por hematêmese volumosa. Na admissão: PA 86 × 50 mmHg, FC 124 bpm, hemoglobina 6,8 g/dL. Recebeu concentrado de hemácias com alvo de hemoglobina entre 7 e 8 g/dL, terlipressina e ceftriaxona; a endoscopia em 6 horas mostrou varizes esofágicas de grosso calibre com sangramento ativo em jato, tratadas com ligadura elástica com sucesso. Hoje está estável, sem novo sangramento, PA 112 × 70 mmHg. Classificação de Child-Pugh: 11 pontos (bilirrubina 3,4 mg/dL, albumina 2,6 g/dL, INR 1,9, ascite leve, sem encefalopatia); creatinina 1,0 mg/dL; ecocardiograma sem disfunção ventricular nem hipertensão pulmonar. Além de manter terlipressina e ceftriaxona, a conduta que reduz a mortalidade é:

A) Propranolol e nova ligadura em 2 semanas

B) TIPS preemptivo nas primeiras 72 horas

C) Balão de Sengstaken-Blakemore profilático

D) Escleroterapia complementar das varizes

---

34 Homem de 68 anos, com DPOC grave (VEF1 de 32% do previsto), foi intubado há 15 minutos por exacerbação com falha da ventilação não invasiva (pH 7,18 e sonolência progressiva). Depois da intubação, foi ventilado com bolsa-válvula de forma vigorosa por alguns minutos e conectado ao ventilador em volume controlado: volume corrente 550 mL, frequência 24 irpm, fluxo inspiratório 40 L/min, PEEP 5 cmH2O, FiO2 60%. Agora a PA caiu de 138 × 82 para 72 × 40 mmHg, FC 128 bpm, SpO2 90%. Pressão de pico 48 cmH2O e de platô 33 cmH2O. Murmúrio vesicular diminuído e simétrico, traqueia centrada, sem enfisema subcutâneo. Na tela do ventilador, a curva de fluxo expiratório não retorna à linha de base antes do ciclo seguinte. A conduta imediata mais adequada é:

A) Punção de alívio no segundo espaço intercostal

B) Desconexão breve do ventilador

C) Aumento da frequência respiratória

D) Aumento da PEEP externa

---

35 Homem de 66 anos, hipertenso, fez eletroforese de proteínas solicitada por "proteínas totais um pouco altas" num check-up. Está assintomático, sem dor óssea, neuropatia, edema ou infecções de repetição. Exames: pico monoclonal de 0,8 g/dL na fração gama, imunofixação IgG kappa, razão de cadeias leves livres kappa/lambda de 1,4 (VR 0,26 a 1,65), Hb 14,2 g/dL, creatinina 0,9 mg/dL, cálcio 9,4 mg/dL, albumina 4,2 g/dL e proteinúria ausente. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Biópsia de gordura abdominal

B) Eletroforese e hemograma em 6 meses

C) Tomografia de corpo inteiro de baixa dose

D) Mielograma e biópsia de medula

---

36 Homem de 34 anos, com HIV e abandono da TARV há 2 anos, CD4 38 células/mm³, procura atendimento por dispneia progressiva há 6 semanas, tosse com escarro raiado de sangue e dor torácica. Está afebril desde o início do quadro e nega sudorese noturna. Exame: T 36,7 °C, FR 26 irpm, SpO2 89% em ar ambiente, lesão violácea plana em palato duro, duas máculas violáceas em coxa direita e linfedema de membros inferiores. TC de tórax: opacidades nodulares mal definidas e espessamento peribroncovascular de distribuição peri-hilar, com derrame pleural bilateral. LDH 210 U/L (VR até 250), beta-D-glucana negativa. Toracocentese: líquido serossanguinolento, exsudato, ADA 12 U/L, citologia sem células neoplásicas. O diagnóstico mais provável é:

A) Sarcoma de Kaposi pulmonar

B) Pneumocistose

C) Tuberculose pulmonar e pleural

D) Linfoma primário de efusão

---

37 Homem de 58 anos, que bebe cerca de 12 latas de cerveja por dia e quase não se alimenta há um mês, é internado às 8 h por confusão leve, sem convulsão. Exames: sódio 108 mEq/L, potássio 3,0 mEq/L, osmolalidade plasmática 228 mOsm/kg, osmolalidade urinária 74 mOsm/kg, sódio urinário menor que 10 mEq/L. Recebeu 100 mL de salina a 3% em bolus, cloreto de potássio intravenoso, tiamina e 500 mL de SF 0,9%, com dieta liberada. Às 16 h está lúcido, o sódio é de 119 mEq/L, a diurese foi de 2.600 mL nas últimas seis horas, com urina clara e osmolalidade urinária de 60 mOsm/kg. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Manter conduta e dosar sódio em 4 h

B) Furosemida e salina isotônica

C) Desmopressina e soro glicosado a 5%

D) Suspender fluidos e observar

---

38 Mulher de 36 anos procura atendimento por palpitações e cansaço aos esforços há 1 ano. Desde a infância tem um sopro que o pediatra considerou inocente. Exame: PA 112×70 mmHg, FC 92 bpm irregular, impulsão sistólica paraesternal esquerda, sopro sistólico ejetivo suave no foco pulmonar, sem clique de ejeção, desdobramento amplo da B2 que não se altera entre inspiração e expiração, e sopro mesodiastólico suave em borda esternal esquerda baixa. ECG: fibrilação atrial, bloqueio incompleto de ramo direito, eixo do QRS em +110 graus. Radiografia: tronco da artéria pulmonar proeminente e trama vascular pulmonar aumentada. O diagnóstico mais provável é:

A) CIA tipo ostium primum

B) Comunicação interventricular

C) Estenose pulmonar valvar

D) CIA tipo ostium secundum

---

39 Homem de 68 anos, hipertenso, usa olmesartana 40 mg/dia e anlodipino há 4 anos. Há 7 meses tem 6 a 8 evacuações aquosas por dia, perda de 14 kg e duas internações por desidratação com lesão renal aguda pré-renal. Exame: PA 108 × 66 mmHg, sem edema. Exames: albumina 2,9 g/dL, ferritina 18 ng/mL, anti-transglutaminase IgA e antiendomísio negativos com IgA total normal, calprotectina fecal 60 µg/g, coproparasitológico e pesquisa de Giardia negativos. Endoscopia com biópsias duodenais: atrofia vilositária total, aumento de linfócitos intraepiteliais e espessamento do colágeno subepitelial. HLA-DQ2 e DQ8 ausentes. A causa mais provável da enteropatia é:

A) Enteropatia autoimune

B) Linfoma intestinal de células T

C) Doença celíaca soronegativa

D) Enteropatia por olmesartana

---

40 Homem de 44 anos tem asma iniciada aos 38 anos, de difícil controle, e rinossinusite crônica com pólipos nasais. Usa budesonida-formoterol e montelucaste e, nos últimos 6 meses, fez 3 ciclos de prednisona por crises. Há 3 semanas teve queda do pé direito e, há 5 dias, dificuldade para estender o punho esquerdo, com dor em queimação nos dois territórios. Exame físico: sibilos difusos, lesões purpúricas palpáveis em pernas, fraqueza da dorsiflexão do pé direito e da extensão do punho esquerdo, com hipoestesia nos territórios correspondentes. Exames: leucócitos 14.200/mm³ com 31% de eosinófilos, IgE total 1.400 UI/mL, IgE específica para Aspergillus fumigatus reagente, p-ANCA e c-ANCA não reagentes, creatinina 0,9 mg/dL, EAS normal, troponina normal. TC de tórax: opacidades em vidro fosco periféricas e migratórias, sem bronquiectasias centrais. O diagnóstico mais provável é:

A) Síndrome hipereosinofílica idiopática

B) Granulomatose eosinofílica com poliangeíte

C) Aspergilose broncopulmonar alérgica

D) Pneumonia eosinofílica crônica

---

41 Mulher de 38 anos, com insuficiência adrenal primária autoimune há cinco anos, usa hidrocortisona 10 mg ao acordar e 5 mg às 14 horas e fludrocortisona 0,1 mg/dia, com PA e potássio controlados. Há um dia tem febre de 38,6 °C, mialgia, coriza e tosse seca, em período de circulação de influenza. Alimenta-se e hidrata-se normalmente, sem vômitos ou diarreia. Exame: PA 118/74 mmHg sem variação postural, FC 96 bpm, sem desidratação. Quanto à hidrocortisona e à fludrocortisona, a conduta é, respectivamente:

A) Manter a dose / manter a dose

B) Dobrar a dose / manter a dose

C) Dobrar a dose / dobrar a dose

D) 100 mg intramuscular / manter a dose

---

42 Mulher de 71 anos, internada há 4 dias por erisipela em membro inferior, recebe cefazolina e enoxaparina 40 mg SC uma vez ao dia, com a última dose há 6 horas. Às 10 h, a enfermeira a encontra com hemiparesia esquerda, hipoestesia esquerda e disartria; estava conversando normalmente às 9h20. NIHSS 9. PA 172/94 mmHg, glicemia 148 mg/dL, plaquetas 210.000/mm³, INR 1,0 e TTPa normal. TC de crânio sem contraste: sem hemorragia, ASPECTS 9. Angiotomografia: sem oclusão de grande vaso; carótidas sem estenose. A conduta mais adequada é:

A) Trombectomia mecânica isolada

B) AAS 300 mg, sem trombólise

C) Dosar anti-Xa antes de decidir

D) Trombólise IV com tenecteplase

---

43 Mulher de 44 anos, com granulomatose com poliangiite em remissão há 1 ano, em manutenção com rituximabe semestral, procura o ambulatório por dispneia progressiva e cansaço há 5 dias. Nega hemoptise, febre, escarro purulento e dor torácica. Exame: T 36,9 °C, FR 24 irpm, SpO2 91% em ar ambiente, PA 128 × 80 mmHg, estertores finos bilaterais, sem edema. Hemoglobina 8,4 g/dL (há 1 mês, 12,1), leucócitos 7.800/mm³, PCR 3,2 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, urina tipo 1 sem hematúria, procalcitonina 0,08 ng/mL. TC: vidro fosco bilateral difuso, sem consolidação lobar. Ecocardiograma normal. DLCO 132% do previsto (há 6 meses, 88%). O diagnóstico mais provável é:

A) Hemorragia alveolar difusa

B) Pneumonite por rituximabe

C) Pneumonia bacteriana bilateral

D) Pneumonia por Pneumocystis

---

44 Homem de 58 anos, portador de bioprótese aórtica há 4 anos, trabalha em uma criação de cabras e ajuda nos partos dos animais. Há 3 meses tem febre baixa intermitente, sudorese noturna, astenia e perda de 6 kg. Há 5 semanas recebeu amoxicilina por 7 dias para sinusite, sem melhora. Exame: T 37,9 °C, sopro diastólico aspirativo novo em foco aórtico, hepatoesplenomegalia discreta, baqueteamento digital, sem lesões cutâneas. Hb 10,8 g/dL, plaquetas 110.000/mm³, VHS 88 mm, ALT 72 U/L, fator reumatoide positivo, hematúria microscópica. Seis pares de hemoculturas, colhidos em 3 dias sem antibiótico e incubados por 14 dias, são negativos. Ecocardiograma transesofágico: espessamento e vegetação de 4 mm na bioprótese, com regurgitação moderada. O exame que deve ser solicitado a seguir é:

A) Novas hemoculturas sem antibiótico

B) PET-CT com FDG

C) Sorologia para Coxiella burnetii

D) Fator antinuclear e anti-DNA

---

45 Homem de 58 anos, com cirrose por vírus C, Child-Pugh C, é internado por aumento do volume abdominal, desconforto respiratório leve e febre baixa há 2 dias. Exame: T 37,9 °C, ascite volumosa, sem petéquias, sem sangramentos ativos. Exames: Hb 10,2 g/dL, plaquetas 48.000/mm³, INR 2,3, fibrinogênio 160 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL. Será feita paracentese diagnóstica e de alívio. Quanto à hemostasia, antes do procedimento, a conduta mais adequada é:

A) Plaquetas até acima de 50.000

B) Plasma fresco até INR abaixo de 1,5

C) Puncionar sem hemocomponente

D) Vitamina K e adiar por 24 horas

---

46 Mulher de 57 anos, hipertensa em uso de losartana e hidroclorotiazida, suspendeu os remédios há 10 dias por falta do medicamento e vem à emergência após medir a pressão na farmácia. Está assintomática, sem cefaleia, dor torácica, dispneia, déficit focal ou alteração visual, mas muito ansiosa. PA 214×124 mmHg confirmada em três medidas após 15 minutos de repouso, FC 84 bpm. Fundo de olho com cruzamentos arteriovenosos patológicos, sem hemorragias, exsudatos ou papiledema. ECG com sobrecarga de VE, sem alterações agudas; creatinina 0,9 mg/dL, urina sem hematúria, troponina normal. A conduta mais adequada é:

A) Reiniciar anti-hipertensivo oral e reavaliar em dias

B) Nitroprussiato IV com redução de 25% na 1ª hora

C) Captopril sublingual até PA abaixo de 140×90

D) Benzodiazepínico e nova medida em 1 hora

---

47 Homem de 27 anos recebeu o diagnóstico de glomerulonefrite após faringite há 14 semanas, com hematúria dismórfica, edema, hipertensão, ASLO elevada, C3 baixo e C4 normal. Foi tratado com restrição de sódio, furosemida e anlodipino. Hoje está sem edema, com PA de 128/82 mmHg. Exames: creatinina 1,3 mg/dL (era 1,4 mg/dL na fase aguda), urina com 40 hemácias por campo, dismórficas, proteinúria de 24 h de 1,6 g (era 1,2 g), C3 42 mg/dL (90 a 180), C4 22 mg/dL (10 a 40), FAN não reagente, anti-HCV negativo, crioglobulinas negativas, eletroforese de proteínas sem pico monoclonal. O próximo passo mais adequado é:

A) Prednisona em dose imunossupressora

B) Biópsia renal percutânea

C) Repetir C3 em oito semanas

D) Antibiótico para erradicar estreptococo

---

48 Mulher de 47 anos, obesa, tem cólica biliar há 2 dias, sem febre. Exame: Tax 36,9 °C, FC 86 bpm, anictérica, dor leve em hipocôndrio direito, Murphy negativo. Exames: leucócitos 8.900/mm³, bilirrubina total 2,4 mg/dL, fosfatase alcalina 310 U/L, GGT 420 U/L, ALT 180 U/L, lipase normal. Ultrassonografia: colelitíase múltipla com cálculos pequenos, vesícula de paredes finas, colédoco de 8 mm, sem cálculo visível no colédoco. O serviço não dispõe de colangiografia nem de ultrassonografia intraoperatórias. Antes da colecistectomia, o exame mais adequado é:

A) Colangiorressonância

B) TC de abdome com contraste

C) CPRE com papilotomia

D) Nenhum, colecistectomia sem exame prévio

---

49 Mulher de 61 anos, com IMC de 33 kg/m², hipertensa, diabética tipo 2 e com doença renal crônica estágio 3b (TFGe 38 mL/min/1,73 m²), refere dor no joelho direito há 1 ano, ao subir escadas e ao final do dia, com rigidez matinal de 10 minutos. Nunca fez tratamento, apenas dipirona eventual. Exame físico: crepitação e osteófitos palpáveis no joelho direito, sem derrame, sem calor, sem instabilidade, marcha preservada. Radiografia: redução do espaço articular medial com osteófitos marginais e esclerose subcondral (Kellgren-Lawrence grau 3). VHS e PCR normais. A conduta inicial mais adequada é:

A) Exercício, perda de peso e AINE tópico

B) Viscossuplementação com ácido hialurônico

C) Naproxeno oral contínuo

D) Encaminhar para artroplastia total

---

50 Homem de 45 anos foi submetido a ressecção transesfenoidal de macroadenoma não funcionante. Nos dois primeiros dias pós-operatórios teve diurese de 6 a 7 L/dia, sódio de 148 mEq/L e osmolalidade urinária de 140 mOsm/kg, e recebeu desmopressina; teve alta no quarto dia com desmopressina 0,1 mg por via oral de 12 em 12 horas e hidrocortisona 15 mg/dia. No oitavo dia pós-operatório volta com náuseas, cefaleia e confusão leve. Exame: euvolêmico, PA 124/78 mmHg, FC 76 bpm, sem hipotensão postural. Exames: sódio 121 mEq/L, osmolalidade plasmática 252 mOsm/kg, osmolalidade urinária 610 mOsm/kg, sódio urinário 68 mEq/L, potássio 4,1 mEq/L, glicemia 96 mg/dL. A causa mais provável da hiponatremia é:

A) Deficiência de cortisol

B) Perda cerebral de sal

C) Secreção inapropriada de ADH

D) Polidipsia primária

---

51 Mulher de 29 anos teve encefalite herpética confirmada por PCR no líquor, tratada com aciclovir IV por 21 dias, com boa recuperação e alta há 3 semanas. Retorna trazida pela mãe por insônia, agitação, frases desconexas e movimentos involuntários da boca e dos membros há 6 dias, sem febre. Exame: Tax 36,9 °C, FC oscilando entre 58 e 128 bpm, discinesias orofaciais e coreoatetose em membros superiores, sem rigidez de nuca. RM de encéfalo: sequela temporal esquerda, sem lesão nova ou realce. Líquor: 18 células/mm³ (linfócitos), proteína 52 mg/dL, glicose normal, PCR para herpes simples negativa. EEG: atividade lenta difusa. A etiologia mais provável do quadro atual é:

A) Encefalite autoimune anti-receptor NMDA

B) Epilepsia focal pós-encefalítica

C) Neurotoxicidade pelo aciclovir

D) Recidiva da encefalite herpética

---

52 Homem de 29 anos, que faz sexo com homens e usa PrEP há 1 ano, procura atendimento por dor anal intensa, tenesmo e secreção mucopurulenta há 5 dias, precedidos de febre e mialgia. Há 3 dias surgiram 6 lesões em face, tronco e região perianal: pápulas e pústulas firmes, umbilicadas, algumas com crosta central. Teve sífilis tratada há 8 meses. Exame: T 37,9 °C, linfonodos inguinais dolorosos de 2 cm, proctite à anuscopia. Teste rápido para HIV não reagente, VDRL 1:2 (era 1:2 há 6 meses). O exame que confirma o diagnóstico mais provável e o período de isolamento recomendado são, respectivamente:

A) Sorologia IgM / 21 dias do início

B) Sorologia IgM / até a reepitelização

C) PCR de lesão / 21 dias do início

D) PCR de lesão / até a reepitelização

---

53 Mulher de 41 anos, que nunca fumou, sem exposição ocupacional e sem antecedente pessoal ou familiar de câncer, fez TC de tórax na emergência após acidente de carro, sem lesões traumáticas. O laudo descreve nódulo sólido único de 4 mm, de contornos regulares, no lobo inferior esquerdo, e recomenda controle evolutivo. Ela tratou infecção latente por tuberculose há 6 anos, após contato com o pai. Está assintomática e muito ansiosa, com exame físico normal. Quanto ao seguimento do nódulo, o exame mais adequado é:

A) TC de tórax em 12 meses

B) TC de tórax em 3 meses

C) PET-CT para caracterização

D) Nenhum seguimento de rotina

---

54 Homem de 70 anos, com leucemia linfocítica crônica diagnosticada há 3 anos em estádio Binet A, sem tratamento, procura atendimento por cansaço e urina escura há 10 dias. Nega febre e sudorese. Linfonodos cervicais de 1,5 cm e baço a 2 cm do rebordo, como nas consultas anteriores. Exames: Hb 7,6 g/dL (13,4 há 6 meses), VCM 108 fL, reticulócitos 11%, leucócitos 42.000/mm³ (86% de linfócitos), plaquetas 168.000/mm³, LDH 690 U/L, haptoglobina indetectável, bilirrubina indireta 2,8 mg/dL, teste de Coombs direto positivo (IgG). O mecanismo da anemia e a conduta inicial são, respectivamente:

A) Infiltração medular / tratar a LLC

B) Infiltração medular / transfusão isolada

C) Hemólise autoimune / prednisona

D) Hemólise autoimune / tratar a LLC

---

55 Homem de 50 anos está internado há 35 dias por pancreatite aguda necrosante de origem biliar. No 18º dia teve febre, e a TC mostrou gás em coleção necrótica; iniciado meropeném, houve melhora inicial. Há 4 dias voltou a ter febre diária de 38,6 °C e taquicardia, sem hipotensão, mantendo dieta enteral por sonda. Exame: FC 112 bpm, PA 118 × 72 mmHg, massa epigástrica dolorosa, sem peritonite. Exames: leucócitos 19.000/mm³, PCR 210 mg/L, lactato 1,4 mmol/L. TC de hoje: necrose encapsulada de 13 cm, com parede bem definida, conteúdo heterogêneo com gás, em contato com a parede posterior do estômago; sem pseudoaneurisma. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Drenagem endoscópica transmural

B) Manter meropeném isolado por 4 semanas

C) Trocar meropeném por polimixina

D) Necrosectomia cirúrgica aberta

---

56 Homem de 83 anos, 64 kg, creatinina 1,3 mg/dL (clearance estimado de 39 mL/min), com fibrilação atrial não valvar e CHA2DS2-VA de 4, vai iniciar apixabana. Não usa fármaco que interaja. A dose adequada é:

A) 2,5 mg uma vez ao dia

B) 5 mg de 12 em 12 horas

C) 2,5 mg de 12 em 12 horas

D) 10 mg de 12 em 12 horas por 7 dias

---

57 Homem de 38 anos, com uso de drogas injetáveis no passado, procura atendimento por dor abdominal pós-prandial, perda de 8 kg e dor em queimação nos pés há 3 meses. Há 2 semanas teve dor testicular esquerda e, há 4 dias, queda do pé esquerdo. Exame físico: PA 178 × 108 mmHg (antes normotenso), livedo racemoso em coxas, nódulos subcutâneos dolorosos em pernas, orquite esquerda, fraqueza da dorsiflexão do pé esquerdo. Exames: Hb 11 g/dL, leucócitos 13.400/mm³ sem eosinofilia, creatinina 1,4 mg/dL, EAS sem hemácias e sem cilindros, proteinúria 0,3 g/24 h, c-ANCA e p-ANCA não reagentes, crioglobulinas negativas, HBsAg e HBeAg reagentes, HBV-DNA 8,2 log UI/mL, ALT 96 U/L, anti-HCV não reagente. Angiotomografia: microaneurismas em artérias renais interlobares e na mesentérica superior. O diagnóstico e o tratamento mais adequados são, respectivamente:

A) PAN associada ao HBV / ciclofosfamida e corticoide prolongado

B) PAN associada ao HBV / antiviral, corticoide breve e plasmaférese

C) Poliangeíte microscópica / ciclofosfamida e corticoide prolongado

D) Poliangeíte microscópica / antiviral, corticoide breve e plasmaférese

---

58 Mulher de 63 anos, com doença do refluxo em uso de omeprazol 40 mg/dia há sete anos e hipertensão controlada com anlodipino, é internada por fraqueza e palpitações. Nega diarreia, vômitos, diurético, laxante ou álcool. Exame: PA 128/78 mmHg, FC 96 bpm irregular, sem tetania. ECG: extrassístoles ventriculares frequentes e QTc de 500 ms. Recebeu 120 mEq de cloreto de potássio por via venosa e oral nas últimas 48 horas, e o potássio passou de 2,7 para 3,0 mEq/L. Outros exames: sódio 139 mEq/L, bicarbonato 26 mEq/L, cálcio total 7,6 mg/dL, albumina 4,0 g/dL, fósforo 3,6 mg/dL, PTH 18 pg/mL (15 a 65), creatinina 0,8 mg/dL, potássio urinário 36 mEq/L. O próximo exame mais adequado é:

A) Magnésio sérico

B) Pesquisa genética para Gitelman

C) Cálcio urinário de 24 horas

D) Renina e aldosterona plasmáticas

---

59 Homem de 33 anos, com HIV diagnosticado junto com tuberculose ganglionar cervical (TRM-TB detectado no aspirado, sem resistência à rifampicina), CD4 inicial 46 células/mm³ e carga viral 410.000 cópias/mL. Iniciou RHZE e, 2 semanas depois, tenofovir, lamivudina e dolutegravir 50 mg de 12/12 horas. Vinha com boa adesão, afebril e com redução dos linfonodos. Três semanas após o início da TARV, volta a ter febre de 38,8 °C e aumento doloroso dos linfonodos cervicais, um deles flutuante, além de pequeno derrame pleural à direita. Exame: PA 118 × 76 mmHg, SpO2 97%, sem sinais meníngeos. CD4 atual 168 células/mm³, carga viral 1.200 cópias/mL. Hemoculturas negativas, radiografia sem consolidação. A conduta mais adequada é:

A) Manter RHZE e TARV e associar prednisona

B) Suspender a TARV até a melhora clínica

C) Trocar para esquema de TB resistente

D) Suspender o RHZE e repetir o TRM-TB

---

60 Mulher de 64 anos, hipertensa e dislipidêmica, chega ao PS 2 horas após início súbito de dormência na face e na mão direitas e leve imprecisão na fala, que persistem. Exame: hipoestesia em face e mão direitas e disartria leve; força normal, sem afasia, sem negligência e sem hemianopsia; NIHSS 2. Ela consegue trabalhar e cuidar da casa com os déficits atuais. PA 156/90 mmHg, glicemia 124 mg/dL, ECG em ritmo sinusal. TC de crânio sem contraste normal; angiotomografia sem oclusão de grande vaso e sem estenose carotídea significativa. Não usa antitrombóticos. A conduta mais adequada é:

A) AAS isolado por tempo indeterminado

B) Apixabana em dose plena

C) Tenecteplase em bolus

D) AAS e clopidogrel por 21 dias

---

61 Mulher de 30 anos, com microprolactinoma de 6 mm diagnosticado por amenorreia e galactorreia, usa cabergolina 0,5 mg por semana há 14 meses, com prolactina normalizada e retorno dos ciclos. Desejava engravidar e tem teste de gravidez positivo, com cinco semanas de gestação. Assintomática, sem cefaleia ou queixa visual. Exame neurológico e campimetria de confrontação normais. Prolactina atual: 48 ng/mL. Em relação ao prolactinoma, a conduta mais adequada durante a gestação é:

A) Suspender a cabergolina e observar

B) Manter a cabergolina até o parto

C) Ressonância de sela trimestral

D) Dosar prolactina a cada trimestre

---

62 Mulher de 58 anos com melanoma metastático em uso de ipilimumabe e nivolumabe (3º ciclo há 3 semanas) apresenta ALT de 680 U/L e AST de 540 U/L (referência até 40 U/L), bilirrubina total 1,1 mg/dL e INR 1,0, assintomática. Sem álcool, paracetamol ou medicamento novo; sorologias virais negativas; ultrassonografia com Doppler sem metástases hepáticas e sem trombose. A imunoterapia foi suspensa e iniciada metilprednisolona 1,5 mg/kg/dia. Após 4 dias, ALT 610 U/L e AST 470 U/L, sem sinais de insuficiência hepática. Quanto ao corticoide e ao imunossupressor a associar, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Manter corticoide / associar infliximabe

B) Manter corticoide / associar micofenolato

C) Suspender corticoide / associar micofenolato

D) Suspender corticoide / associar infliximabe

---

63 Homem de 45 anos, que bebe 3 doses por semana, está no 4º mês de tratamento de tuberculose pulmonar com rifampicina e isoniazida, com boa resposta clínica e baciloscopia negativa. Queixa cansaço progressivo há 1 mês. Exames: Hb 8,2 g/dL, VCM 71 fL, RDW 24%, reticulócitos 0,8%, ferro sérico 210 mcg/dL, saturação de transferrina 82%, ferritina 940 ng/mL, PCR 0,6 mg/dL, vitamina B12 e folato normais. Esfregaço: população dupla de hemácias, microcíticas hipocrômicas e normocíticas, com corpúsculos de Pappenheimer. A conduta mais adequada para a anemia é:

A) Sulfato ferroso oral

B) Piridoxina, mantendo o esquema

C) Alfaepoetina subcutânea

D) Suspender o esquema antituberculose

---

64 Homem de 62 anos, hipertenso, sem internações ou uso de antibiótico nos últimos 6 meses, chega com febre, tosse e dispneia há 3 dias. FR 34 irpm, SpO2 86% em ar ambiente, PA 118 × 70 mmHg sem vasopressor, confuso, ureia 62 mg/dL. Radiografia: consolidação multilobar à direita. Foi para a UTI e está em cateter nasal de alto fluxo com FiO2 de 60%, com PaO2 de 84 mmHg. Iniciados ceftriaxona e azitromicina após hemoculturas. PCR para influenza e SARS-CoV-2 negativos; swab nasal para MRSA negativo; glicemia 168 mg/dL; sem uso prévio de corticoide. Além de manter o antibiótico, a medida adicional com benefício em mortalidade demonstrado neste perfil de paciente é:

A) Hidrocortisona intravenosa

B) Associar vancomicina

C) Oseltamivir empírico

D) Trocar ceftriaxona por meropenem

---

65 Homem de 63 anos, hipertenso há 20 anos, procura atendimento por dispneia aos esforços há 6 meses. Refere dores lancinantes nas pernas há anos e dificuldade para andar no escuro. Exame: marcha talonante, Romberg positivo, reflexos aquileus e patelares abolidos, pupilas pequenas e irregulares que não reagem à luz e se contraem na acomodação. PA 158×60 mmHg, FC 80 bpm, ictus desviado para o 6º espaço intercostal na linha axilar anterior. Radiografia de tórax: alargamento do mediastino superior e calcificação linear da parede da aorta ascendente. O achado auscultatório mais provável é:

A) Sopro diastólico aspirativo em borda esternal direita

B) Sopro holossistólico apical irradiado para a axila

C) Ruflar diastólico apical com estalido de abertura

D) Sopro sistólico ejetivo irradiado para as carótidas

---

66 Homem de 68 anos, com diabetes tipo 2 há 12 anos, retinopatia diabética não proliferativa e hipertensão, tinha creatinina de 1,3 mg/dL há seis meses. Há dois meses tem fadiga e dor lombar. Exames: creatinina 3,9 mg/dL, hemoglobina 9,1 g/dL, cálcio 10,9 mg/dL, albumina 3,8 g/dL, proteínas totais 6,4 g/dL, glicemia 168 mg/dL. Urina: fita reagente com traços de proteína, sem hematúria, sem leucocitúria; proteinúria de 24 h de 3,6 g; relação albumina/creatinina urinária de 40 mg/g. Ultrassonografia: rins de 11,5 cm, sem hidronefrose. A causa mais provável da lesão renal é:

A) Doença renal do diabetes

B) Nefropatia por cilindros de cadeias leves

C) Amiloidose AL renal

D) Nefropatia membranosa

---

67 Homem de 66 anos tem artrite reumatoide soropositiva há 14 anos, erosiva, controlada com metotrexato 15 mg/semana e ácido fólico. Há 6 meses teve duas pneumonias e, há 2 meses, úlcera em perna. Exame físico: sinovite discreta em 2 metacarpofalângicas, nódulos reumatoides em cotovelos, baço palpável a 3 cm do rebordo costal, sem linfonodomegalias. Exames: Hb 11,2 g/dL, leucócitos 5.600/mm³ com neutrófilos 400/mm³ e linfócitos 4.800/mm³, plaquetas 190.000/mm³, VCM 92 fL. Citometria de fluxo: população CD3+, CD8+, CD57+ e CD16+ expandida, com rearranjo clonal do receptor de célula T. Vitamina B12 e folato normais. O diagnóstico mais provável é:

A) Neutropenia por metotrexato

B) Leucemia linfocítica crônica

C) Leucemia de linfócitos grandes granulares T

D) Síndrome de Felty

---

68 Homem de 46 anos, diabético em uso de glibenclamida, procura o pronto-socorro por cefaleia holocraniana intensa, febre, fotofobia e vômitos há 3 dias; não se alimenta desde ontem. A esposa está no 2º mês de tratamento para tuberculose pulmonar bacilífera. Nega uso de antibióticos. Exame: T 38,4 °C, PA 128 × 80 mmHg, FC 98 bpm, Glasgow 15, rigidez de nuca, sem déficit focal ou paralisia de nervos cranianos; pele fria e sudoreica. Anti-HIV não reagente. TC de crânio normal. Líquor: pressão de abertura 18 cmH2O, límpido, 160 células/mm³ (85% linfócitos), proteína 74 mg/dL, glicose 30 mg/dL, lactato 2,1 mmol/L (VR até 2,8), ADA 3 U/L, Gram e tinta da China negativos. Glicemia capilar colhida no momento da punção: 48 mg/dL. O diagnóstico mais provável é:

A) Meningite criptocócica

B) Meningite viral

C) Meningite bacteriana decapitada

D) Meningite tuberculosa

---

69 Mulher de 59 anos com cirrose por esteato-hepatite metabólica, Child-Pugh B, recebe alta após o segundo episódio de encefalopatia hepática grau 3 em 5 meses, ambos tratados com lactulose. No primeiro, o precipitante foi infecção urinária; neste, não se identificou precipitante (sem infecção, sangramento, distúrbio eletrolítico, constipação ou sedativo). Desde o primeiro episódio usava lactulose ajustada para 2 a 3 evacuações pastosas por dia, com boa adesão confirmada pela família. Na alta: orientada, sem asterixis; albumina 3,0 g/dL, sódio 134 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL. Para prevenção de novo episódio, quanto ao tratamento farmacológico e à oferta proteica, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Manter só lactulose / proteína 0,6 g/kg/dia

B) Manter só lactulose / proteína 1,2 a 1,5 g/kg/dia

C) Associar rifaximina / proteína 0,6 g/kg/dia

D) Associar rifaximina / proteína 1,2 a 1,5 g/kg/dia

---

70 Homem de 62 anos, com diabetes tipo 2 há 8 anos (HbA1c 7,1%), apresenta há 5 semanas dor em queimação e fraqueza súbita para dorsiflexão do pé esquerdo; 2 semanas depois, mão direita caída; há 10 dias, dormência no território do ulnar esquerdo. Perdeu 6 kg e tem febre baixa noturna. Exame: pé esquerdo caído, punho direito caído, hipoestesia nos territórios correspondentes. VHS 88 mm/h, PCR 6,2 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, EAS normal, ANCA, FAN e crioglobulinas negativos, HBsAg e anti-HCV não reagentes. Eletroneuromiografia: neuropatia axonal multifocal assimétrica (fibular esquerdo, radial direito, ulnar esquerdo). O próximo passo mais adequado é:

A) Imunoglobulina IV empírica

B) Biópsia de nervo e músculo

C) Pregabalina e ajuste glicêmico

D) Arteriografia mesentérica e renal

---

71 Homem de 52 anos está na UTI há 18 dias por pancreatite necrotizante infectada, em jejum com nutrição parenteral e recebendo meropeném há 12 dias. Hoje apresenta sangramento em sítios de punção e hematúria, sem instabilidade hemodinâmica. Exames: Hb 9,1 g/dL, plaquetas 210.000/mm³, INR 3,4, TTPa 44 s (controle 30 s), fibrinogênio 420 mg/dL, D-dímero discretamente elevado, fator V 96%, fator VII 14%, AST 40 U/L, ALT 35 U/L, bilirrubina total 1,1 mg/dL, albumina 2,9 g/dL. O TP corrigiu por completo no teste da mistura com plasma normal. A causa mais provável da coagulopatia é:

A) Deficiência de vitamina K

B) Coagulação intravascular disseminada

C) Insuficiência hepática da sepse

D) Inibidor adquirido de fator

---

72 Mulher de 59 anos, com obesidade (IMC 35 kg/m²), hipertensão e pré-diabetes, foi orientada a apenas perder peso após ultrassonografia com esteatose leve e enzimas hepáticas consideradas normais. Consome uma dose de álcool por semana. Sorologias para hepatites B e C negativas, ferritina 180 ng/mL com saturação de transferrina 26%. Exame: sem estigmas de hepatopatia, baço não palpável. Exames: AST 40 U/L (até 40), ALT 36 U/L (até 41), plaquetas 182.000/mm³, albumina 4,3 g/dL, bilirrubinas normais. O risco de fibrose avançada pelo FIB-4 e o próximo passo são, respectivamente:

A) Baixo / repetir o FIB-4 em um a três anos

B) Intermediário / elastografia hepática

C) Intermediário / biópsia hepática

D) Alto / encaminhar ao hepatologista

---

73 Mulher de 69 anos recebe dipirona venosa no pronto-socorro e, em 10 minutos, apresenta urticária difusa, sibilos, rouquidão e PA de 70 × 40 mmHg. Recebeu adrenalina 0,5 mg intramuscular na coxa, repetida 5 e 10 minutos depois, 2 litros de cristaloide e oxigênio, sem melhora: mantém PA de 76 × 44 mmHg, FC de 54 bpm e sibilos. Refere glaucoma, tratado há 4 anos com um colírio, e hipotireoidismo em levotiroxina. Nega outras medicações. A explicação mais provável para a refratariedade é:

A) Betabloqueio pelo colírio

B) Dose insuficiente de adrenalina

C) Reação bifásica

D) Mastocitose sistêmica

---

74 Homem de 61 anos, portador de prótese mecânica mitral há 8 anos, em anticoagulação oral estável há 2 anos, com dieta e adesão regulares, recebe diagnóstico de tuberculose pulmonar com TRM-TB detectado, sem resistência à rifampicina. Não tem outras doenças, creatinina 1,0 mg/dL, ALT 30 U/L. Será iniciado RHZE em dose plena por peso. Em relação à anticoagulação, a conduta mais adequada é:

A) Trocar por anticoagulante oral direto

B) RNI semanal e aumento da dose

C) Manter a dose e o controle habitual

D) Suspender o anticoagulante durante o RHZE

---

75 Homem de 32 anos tem diagnóstico recente de infecção pelo HIV (CD4 480 células/mm³, carga viral 38.000 cópias/mL) e está assintomático. Na triagem: HBsAg reagente, HBeAg não reagente, anti-HBe reagente, HBV-DNA 900 UI/mL, ALT 24 U/L (referência até 40 U/L), elastografia hepática 5,1 kPa, anti-HCV não reagente; genotipagem pré-tratamento do HIV sem mutações de resistência. Creatinina 0,9 mg/dL, sem proteinúria e sem doença óssea. Ele deseja o esquema com menos comprimidos possível. O esquema antirretroviral inicial mais adequado é:

A) Entecavir e adiar a TARV

B) Dolutegravir e lamivudina

C) Tenofovir, lamivudina e dolutegravir

D) Zidovudina, lamivudina e dolutegravir

---

76 Mulher de 31 anos tem LES há 6 anos, com artrite, fotossensibilidade e leucopenia, sem nefrite, em remissão há 2 anos com hidroxicloroquina 400 mg/dia. Anti-Ro/SSA reagente em título alto, anti-La/SSB não reagente, anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta2-glicoproteína I não reagentes. Está com 8 semanas de gestação planejada e pergunta se deve parar a hidroxicloroquina, porque leu que remédios fazem mal ao bebê. PA 112 × 70 mmHg, EAS sem proteinúria, C3 e C4 normais, anti-DNA nativo não reagente. Quanto à hidroxicloroquina e à vigilância fetal específica do anti-Ro, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Manter / ecocardiografia fetal seriada de 16 a 26 semanas

B) Manter / dexametasona profilática desde agora

C) Suspender / ecocardiografia fetal seriada de 16 a 26 semanas

D) Suspender / dexametasona profilática desde agora

---

77 Mulher de 69 anos, com diabetes em uso de insulina NPH, hipertensa, creatinina 1,1 mg/dL, vai a colecistectomia videolaparoscópica eletiva por colelitíase sintomática. Caminha 3 km por dia e sobe dois andares de escada sem parar e sem sintomas. Nega angina, dispneia, síncope e palpitações. Exame: PA 132×80 mmHg, FC 70 bpm, sem sopros, sem sinais de congestão. ECG: bloqueio de ramo esquerdo, já presente em traçado de 4 anos atrás. Em relação à avaliação cardiovascular pré-operatória, a conduta mais adequada é:

A) Cintilografia com estresse farmacológico

B) Ecocardiograma com estresse farmacológico

C) Operar sem teste de isquemia

D) Cineangiocoronariografia

---

78 Mulher de 71 anos, no terceiro dia de UTI por choque séptico de foco pulmonar, em ventilação mecânica com FiO2 de 0,7 e PEEP de 12 cmH2O (relação PaO2/FiO2 de 105), recebe noradrenalina 0,3 µg/kg/min. Balanço hídrico acumulado de +9 litros, com edema generalizado, e radiografia com congestão e infiltrados bilaterais. A creatinina subiu de 0,8 para 2,7 mg/dL. Nas últimas 12 horas, recebeu furosemida 80 mg IV em bolus seguida de infusão de 20 mg/h, com diurese total de 180 mL. Exames: potássio 4,8 mEq/L, bicarbonato 19 mEq/L, pH 7,31, ureia 96 mg/dL. Quanto à terapia renal substitutiva, a indicação e o método são, respectivamente:

A) Indicada agora / método contínuo

B) Indicada agora / método intermitente

C) Ainda não indicada / contínuo se piorar

D) Ainda não indicada / intermitente se piorar

---

79 Homem de 29 anos, com asma desde a adolescência, tem prescritos fluticasona-salmeterol 250/50 mcg duas vezes ao dia e salbutamol de resgate. Tem sintomas diurnos quase diários, acorda com tosse duas vezes por semana e teve duas crises tratadas com prednisona oral no último ano. Usa salbutamol cerca de 10 vezes por semana. Conta que usa o inalador de manutenção quando lembra, em geral só nos dias de crise, e o registro da farmácia mostra retirada de 4 dispositivos nos últimos 12 meses. Técnica inalatória correta na demonstração. Eosinófilos 520/mm³, IgE total 410 UI/mL, teste cutâneo positivo para ácaros. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Dobrar a dose de fluticasona-salmeterol

B) Associar tiotrópio ao esquema atual

C) MART com budesonida-formoterol

D) Iniciar mepolizumabe subcutâneo

---

80 Mulher de 79 anos, com fibrilação atrial em uso de dabigatrana 110 mg duas vezes ao dia (última dose há 4 horas), chega com hemiparesia direita, e a tomografia mostra hematoma intraparenquimatoso de 22 mL. Clearance de creatinina estimado de 42 mL/min, plaquetas 190.000/mm³, TTPa 58 s (controle 30 s). Para reverter de forma imediata e específica o efeito anticoagulante, a medida mais adequada é:

A) Complexo protrombínico de 4 fatores

B) Hemodiálise de urgência

C) Andexanete alfa

D) Idarucizumabe

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 4

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1 (A) (B) (C) (D)	2 (A) (B) (C) (D)	3 (A) (B) (C) (D)	4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)	6 (A) (B) (C) (D)	7 (A) (B) (C) (D)	8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)	10 (A) (B) (C) (D)	11 (A) (B) (C) (D)	12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	14 (A) (B) (C) (D)	15 (A) (B) (C) (D)	16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	18 (A) (B) (C) (D)	19 (A) (B) (C) (D)	20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	22 (A) (B) (C) (D)	23 (A) (B) (C) (D)	24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)	26 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
29 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
33 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
37 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
41 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
45 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
49 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)	51 (A) (B) (C) (D)	52 (A) (B) (C) (D)
53 (A) (B) (C) (D)	54 (A) (B) (C) (D)	55 (A) (B) (C) (D)	56 (A) (B) (C) (D)
57 (A) (B) (C) (D)	58 (A) (B) (C) (D)	59 (A) (B) (C) (D)	60 (A) (B) (C) (D)
61 (A) (B) (C) (D)	62 (A) (B) (C) (D)	63 (A) (B) (C) (D)	64 (A) (B) (C) (D)
65 (A) (B) (C) (D)	66 (A) (B) (C) (D)	67 (A) (B) (C) (D)	68 (A) (B) (C) (D)
69 (A) (B) (C) (D)	70 (A) (B) (C) (D)	71 (A) (B) (C) (D)	72 (A) (B) (C) (D)
73 (A) (B) (C) (D)	74 (A) (B) (C) (D)	75 (A) (B) (C) (D)	76 (A) (B) (C) (D)
77 (A) (B) (C) (D)	78 (A) (B) (C) (D)	79 (A) (B) (C) (D)	80 (A) (B) (C) (D)